



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : زكيه فتحي محمد حسن

العنوان : قرية ميت شماس
مركز ابو النمرس

الحي / المدينة : ابوالنمرس

المحافظة : الجيزة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 24-09-2026

رقم البطاقة : 27102122102148 رقم التليفون : 01080620957

العمر(تاريخ الميلاد) : 12-02-1971 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان

الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :

التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د. /..... /د. /..... /د. /..... /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: زكيه فتحي محمد حسن National ID: 27102122102148	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



البوشى سكان للأشعة

Boshy Scan

Name: Zakeya Fathy Mohamed
Ref : Prof. Dr. Ahmed Abd El aaty
Date: 1 September 2026

Thanks for reference

Left breast digital soft tissue mammography & high resolution breast sonography & Elastography revealed :

- Diffuse increased breast density with thickened coarsened trabeculations.
- Moderate thickening and edema of the skin of the left breast.
- Moderate central interstitial edema is noted.
- Left breast upper half irregular shaped infiltrative hypoechoic solid mass lesion is seen at 11-1 O'clock ,about 6 cm from the areola ,measuring 31x16 mm in diameter with surrounding architectural distortion ,being avascular upon Color Doppler application.
- Multiple other similar lesions are seen at the left UIQ ,10 O'clock ,about 3 cm from the areola ,measuring 17x13 mm ,13x11 mm and smaller lesions ,measuring 3-8 mm .
- Pathologically enlarged left axillary tail intramammary LN is seen measuring 48x22 mm .
- Multiple pathologically enlarged left axillary LNs are noted at all levels ,reaching 33x27 mm and 19x14 mm .
- Pathologically enlarged left infraclavicular LNs reaching 19x10 mm .
- Multiple pathologically enlarged left supraclavicular LNs measuring 23x13 mm and 23x21 mm .

OPINION :

Left breast upper half multicentric malignant looking solid mass lesions with left axillary tail intramammary ,left axillary ,left infra and supraclavicular pathological lymphadenopathies **BIRADS 5** ,for U/S guided Tru Cut biopsy.

*Kindly accept my best regards,
Dr. Sara Mahmoud, MD*

Defining BIRADS classification of breast lesions according to the American College of Radiology:

Category

Suspected Cancer Risk

BIRADS 0 : Non-informative study.

BIRADS 1 : Normal study.

0 %

BIRADS 2 : Benign findings.

0 %

BIRADS 3 : Probably benign.

2 %

BIRADS 4 : Probably malignant.

50 %

A : mild suspicion.

B : moderate suspicion.

C : high suspicion.

BIRADS 5 : Malignant

98-100%

BIRADS 6 : Pathologically proven malignant



Boshy Scan 011 515 0000 4

012 707 2222 8

الجوامدية - ش طراد النيل - بجوار قسم الشرطة

For Further Information Regarding This Case Please Don't Hesitate To Contact Us

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



زكية
فتحي محمد حسن
قرية ميت شناس
مركز ابوالنمرس - الجيزة



٢٧١٠٢١٢٢١٠٢١٤٨

KD2847802

Nation ID - Front
[DOC: REPID_F_07]



٢٠٢٣/٠٨ ٢٧١.٢١٢٢١.٢١٤٨

ربة منزل

ارملة

مصلحة

انثى



البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/٠٨/١٥



قسم الباثولوجي

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي
والأمراض المعدية

PATHOLOGY DEPARTMENT HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: زكية فقي محمد حسن	Age: 55 years	Sex: female
Request type: ميلر ه	Sub request type:	
Hospital no:	Pathology no.: 932-2026	
Department: صحة مصر أه	Date of result: 16/9/2026	
Referred by: د/مروه حسن	Date of biopsy: 7/9/2026	
Nature of specimen: tru-cut biopsy	I.D. Number: 27102122102148	
Clinical diagnosis: Left breast mass		

Gross pathology:

Multiple fragmented grayish white tissue cores up to 1cm long, totally submitted.

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against ER- PR- Her2- Ki67

Microscopic picture:

Section examined revealed core of tumor showing invasive duct carcinoma of no special type (NST). The tumor forms nests, tubule and cribriform pattern infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showing marked anaplasia and poor tendency to form tubules. There is moderate number of mitotic figures. Ductal carcinoma insitu component (solid pattern) of low and intermediate grade could be seen.

Immunohistochemical Result

ER: Strong nuclear staining in 90% of tumor cells (Allred Score 8/8).

PR: Weak nuclear staining in 10% of tumor cells (Allred Score 3/8).

Her2: No membranous staining of tumor cells (score 0).

Ki67: Positive nuclear staining of 80% of tumor cells.

Diagnosis: Left breast mass ,Tru-cut biopsy :

Invasive duct carcinoma (NST), Grade III.

Signature:

Dr.Nermine Nabil.M.D

Dr. A
29/9/2026

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D



Women's Health Outreach Program

Name: zakeria fathy Mohamed Date: 6-9-2026

Bilateral limited Digital Mammography and high resolution ultrasound examination

Clinical summary: 55years old female patient with painful swollen left breast from 3 month

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Left breast

- (ACR density B).
- The left breast shows global asymmetrical density ,skin thickening and UIQ architectural distortion and non mass lesion in area bout 13x6x7cm (more appreciable in TOMO view)
- **Ultrasound demonstrated** locally advanced malignant process inform of ill-defined multiple hypoechoic non mass lesion seen taken ductal destruction between 10-11 o'clock measuring about 27x8mm .28x7mm and 35x11mm associated with parenchymal distortion ,with scattered un healthy breast parenchyma seen in rest of breast with global overlying skin thickening and moderate interstitial edema
- Multiple enlarged pathological axillary lymph nodes with thickened cortex level I, II and III. Largest level I measuring 30x20mm .level II measuring 11x8mm level II measuring 10x7mm and supra clavicular pathological lymph nodes largest 9x5m
- **Right breast**
- (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- **Ultrasound demonstrated** no solid or cystic masses.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- **Left breast (BIRADS 5):** Left locally advanced malignant process as described with ipsilateral pathological axillary lymph nodes. for histopathological correlation
- **Right breast (BIRADS 2):** Normal study.

2/1

Best regards,
Dr. Marwa M. Hassan

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الادارة المركزية لتنظيم المعلومات و التحول
الرقمي

رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار: 2026-9-7

الى من يهمه الامر
جهة الاصدار: فرع الجيزة

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 "الاطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من التأمينات الاجتماعيه
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من الضمان الاجتماعي
والبحت تبين أن

السيد (ه) زكيه فتحي محمد حسن بطاقة رقم 27102122102148
تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعة: 2026-9-7



إفادة مركز نظم المعلومات
يعتد...



مسلم 2070557

الخطاب ساري لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ الاصدار الا في حالة تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية او
وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية و التعليم

الادارة المركزية لتنظيم المعلومات و التحول الرقمي

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



زكية
فتحي محمد حسن
قرية ميت شناس
مركز ابوالنمرس - الجيزة

١٩٧٧



٢٧١٠٢١٢٢١٠٢١٤٨

KD2847802



٢٠٢٣/٠٨ ٢٧١.٢١٢٢١.٢١٤٨

ربة منزل

ارملة

مصلحة

انثى



البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/٠٨/١٥

١





Women's Health Outreach Program

Name: zakeya fathy Mohamed Date: 6-9-2026

Bilateral limited Digital Mammography and high resolution ultrasound

examination

Clinical summary: 55years old female patient with painful swollen left breast from 3 month

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Left breast

- (ACR density B).
- The left breast shows global asymmetrical density, skin thickening and UIQ architectural distortion and non mass lesion in area bout 13x6x7cm (more appreciable in TOMO view)
- Ultrasound demonstrated locally advanced malignant process inform of ill-defined multiple hypoechoic non mass lesion seen taken ductal destruction between 10-11 o'clock measuring about 27x8mm .28x7mm and 35x11mm associated with parenchymal distortion ,with scattered un healthy breast parenchyma seen in rest of breast with global overlying skin thickening and moderate interstitial edema
- Multiple enlarged pathological axillary lymph nodes with thickened cortex level I, II and III. Largest level I measuring 30x20mm .level II measuring 11x8mm level II measuring 10x7mm and supra clavicular pathological lymph nodes largest 9x5m
- Right breast
- (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic masses.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- Left breast (BIRADS 5): Left locally advanced malignant process as described with ipsilateral pathological axillary lymph nodes. for histopathological correlation
- Right breast (BIRADS 2): Normal study.

Best regards,

Dr. Marwa M. Hassan

21/

PATHOLOGY DEPARTMENT HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: زكية فقي محمد حسن	Age: 55 years	Sex: female
Request type: ميلر ه	Sub request type:	
Hospital no:	Pathology no.: 932-2026	
Department: صحة مصر الأه	Date of result: 16/9/2026	
Referred by: د/مروه حسن	Date of biopsy: 7/9/2026	
Nature of specimen: tru-cut biopsy	I.D. Number: 27102122102148	
Clinical diagnosis: Left breast mass		

Gross pathology:

Multiple fragmented grayish white tissue cores up to 1cm long, totally submitted.

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against ER- PR- Her2- Ki67

Microscopic picture:

Section examined revealed core of tumor showing invasive duct carcinoma of no special type (NST). The tumor forms nests, tubule and cribriform pattern infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showing marked anaplasia and poor tendency to form tubules. There is moderate number of mitotic figures. Ductal carcinoma insitu component (solid pattern) of low and intermediate grade could be seen.

Immunohistochemical Result

ER: Strong nuclear staining in 90% of tumor cells (Allred Score 8/8).

PR: Weak nuclear staining in 10% of tumor cells (Allred Score 3/8).

Her2: No membranous staining of tumor cells (score 0).

Ki67: Positive nuclear staining of 80% of tumor cells.

Diagnosis: Left breast mass ,Tru-cut biopsy :

Invasive duct carcinoma (NST), Grade III.

Signature:

Dr.Nermine Nabil.M.D

Dr. A
29/9/2026

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D



Women's Health Outreach Program

Name: zakeria fathy Mohamed Date: 6-9-2026

Bilateral limited Digital Mammography and high resolution ultrasound examination

Clinical summary: 55years old female patient with painful swollen left breast from 3 month

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Left breast

- (ACR density B).
- The left breast shows global asymmetrical density ,skin thickening and UIQ architectural distortion and non mass lesion in area bout 13x6x7cm (more appreciable in TOMO view)
- **Ultrasound demonstrated** locally advanced malignant process inform of ill-defined multiple hypoechoic non mass lesion seen taken ductal destruction between 10-11 o'clock measuring about 27x8mm .28x7mm and 35x11mm associated with parenchymal distortion ,with scattered un healthy breast parenchyma seen in rest of breast with global overlying skin thickening and moderate interstitial edema
- Multiple enlarged pathological axillary lymph nodes with thickened cortex level I, II and III. Largest level I measuring 30x20mm .level II measuring 11x8mm level II measuring 10x7mm and supra clavicular pathological lymph nodes largest 9x5m
- **Right breast**
- (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- **Ultrasound demonstrated** no solid or cystic masses.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- **Left breast (BIRADS 5):** Left locally advanced malignant process as described with ipsilateral pathological axillary lymph nodes. for histopathological correlation
- **Right breast (BIRADS 2):** Normal study.

Best regards,

Dr. Marwa M. Hassan

2/1



رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار: 2026-9-7

جهة الاصدار: فرع الجيزة

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 "الاطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من التأمينات الاجتماعيه
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من الضمان الاجتماعي
والبحت تبين أن

السيد (ه) زكيه فتحى محمد حسن بطاقة رقم 27102122102148
تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعة: 2026-9-7



إفادة مركز نظم المعلومات
يعتد،،،



مسلم 2070557

الخطاب سارى لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ الاصدار الا فى حالة تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعيه او
وزارة التضامن الاجتماعى او وزارة التربية و التعليم

الادارة المركزية لتنظيم المعلومات و التحول الرقسي

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



زكية
فتحي محمد حسن
قرية ميت شناس
مركز ابوالنمرس - الجيزة

١٩٧٧



٢٧١٠٢١٢٢١٠٢١٤٨

KD2847802



٢٠٢٣/٠٨ ٢٧١.٢١٢٢١.٢١٤٨

ربة منزل

ارملة

مصلحة

انثى



البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/٠٨/١٥

١





Women's Health Outreach Program

Name: zakeya fathy Mohamed Date: 6-9-2026

Bilateral limited Digital Mammography and high resolution ultrasound

examination

Clinical summary: 55years old female patient with painful swollen left breast from 3 month

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Left breast

- (ACR density B).
- The left breast shows global asymmetrical density, skin thickening and UIQ architectural distortion and non mass lesion in area bout 13x6x7cm (more appreciable in TOMO view)
- Ultrasound demonstrated locally advanced malignant process inform of ill-defined multiple hypoechoic non mass lesion seen taken ductal destruction between 10-11 o'clock measuring about 27x8mm .28x7mm and 35x11mm associated with parenchymal distortion ,with scattered un healthy breast parenchyma seen in rest of breast with global overlying skin thickening and moderate interstitial edema
- Multiple enlarged pathological axillary lymph nodes with thickened cortex level I, II and III. Largest level I measuring 30x20mm .level II measuring 11x8mm level II measuring 10x7mm and supra clavicular pathological lymph nodes largest 9x5m
- Right breast
- (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic masses.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- Left breast (BIRADS 5): Left locally advanced malignant process as described with ipsilateral pathological axillary lymph nodes. for histopathological correlation
- Right breast (BIRADS 2): Normal study.

Best regards,

Dr. Marwa M. Hassan

21/



N H T M R I

قسم الباثولوجي

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي
والأمراض المعدية

PATHOLOGY DEPARTMENT HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: زكية فقي محمد حسن	Age: 55 years	Sex: female
Request type: ميلر ه	Sub request type:	
Hospital no:	Pathology no.: 932-2026	
Department: صحة مصر الأه	Date of result: 16/9/2026	
Referred by: د/مروه حسن	Date of biopsy: 7/9/2026	
Nature of specimen: tru-cut biopsy	I.D. Number: 27102122102148	
Clinical diagnosis: Left breast mass		

Gross pathology:

Multiple fragmented grayish white tissue cores up to 1cm long, totally submitted.

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against ER- PR- Her2- Ki67

Microscopic picture:

Section examined revealed core of tumor showing invasive duct carcinoma of no special type (NST). The tumor forms nests, tubule and cribriform pattern infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showing marked anaplasia and poor tendency to form tubules. There is moderate number of mitotic figures. Ductal carcinoma insitu component (solid pattern) of low and intermediate grade could be seen.

Immunohistochemical Result

ER: Strong nuclear staining in 90% of tumor cells (Allred Score 8/8).

PR: Weak nuclear staining in 10% of tumor cells (Allred Score 3/8).

Her2: No membranous staining of tumor cells (score 0).

Ki67: Positive nuclear staining of 80% of tumor cells.

Diagnosis: Left breast mass ,Tru-cut biopsy :

Invasive duct carcinoma (NST), Grade III.

Signature:

Dr.Nermine Nabil.M.D

Dr. A
29/9/2026

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D



Women's Health Outreach Program

Name: zakeria fathy Mohamed Date: 6-9-2026

Bilateral limited Digital Mammography and high resolution ultrasound examination

Clinical summary: 55years old female patient with painful swollen left breast from 3 month

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Left breast

- (ACR density B).
- The left breast shows global asymmetrical density ,skin thickening and UIQ architectural distortion and non mass lesion in area bout 13x6x7cm (more appreciable in TOMO view)
- **Ultrasound demonstrated** locally advanced malignant process inform of ill-defined multiple hypoechoic non mass lesion seen taken ductal destruction between 10-11 o'clock measuring about 27x8mm .28x7mm and 35x11mm associated with parenchymal distortion ,with scattered un healthy breast parenchyma seen in rest of breast with global overlying skin thickening and moderate interstitial edema
- Multiple enlarged pathological axillary lymph nodes with thickened cortex level I, II and III. Largest level I measuring 30x20mm .level II measuring 11x8mm level II measuring 10x7mm and supra clavicular pathological lymph nodes largest 9x5m
- **Right breast**
- (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- **Ultrasound demonstrated** no solid or cystic masses.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- **Left breast (BIRADS 5):** Left locally advanced malignant process as described with ipsilateral pathological axillary lymph nodes. for histopathological correlation
- **Right breast (BIRADS 2):** Normal study.

Best regards,

Dr. Marwa M. Hassan

2/1



رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار: 2026-9-7

جهة الاصدار: فرع الجيزة

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 "الاطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من التأمينات الاجتماعيه
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من الضمان الاجتماعي
والبحت تبين أن

السيد (ه) زكيه فتحي محمد حسن بطاقة رقم 27102122102148
تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعة: 2026-9-7



إفادة مركز نظم المعلومات
يعتد،،،



مسلم 2070557

الخطاب ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا في حالة تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية و التعليم

الادارة المركزية لتنظيم المعلومات و التحول الرقمي